

CÁC CƠ QUAN SINH DỤC NỮ

(Organa genitalia feminina)

Cơ quan sinh dục nữ bao gồm: các cơ quan sinh dục trong và các cơ quan sinh dục ngoài.

1. Các cơ quan sinh dục trong của nữ (organa genitalia feminina interna)

Các cơ quan sinh dục trong của nữ gồm có: Buồng trứng, vòi tử cung, tử cung và âm đạo.

1.1 Buồng trứng (ovarium)

Buồng trứng là một tuyến sinh dục nữ, có chức năng vừa ngoại tiết (sinh ra trứng), vừa nội tiết (tiết ra nội tiết tố nữ, đó là eostrogen và progesteron) quyết định giới tính phụ của nữ. Có hai buồng trứng: Một bên phải và một bên trái.

Vị trí buồng trứng thay đổi tùy theo người chưa sinh đẻ, sinh đẻ ít hay đã đẻ nhiều lần. Ở người chưa sinh, buồng trứng áp vào thành bên chậu hông bé, hai bên tử cung, dính vào lá sau dây chằng rộng, dưới eo trên khoảng 10mm. Đối chiếu lên thành bụng điểm buồng trứng là điểm giữa đường nối giữa gai chậu trước trên và khớp mu.

Buồng trứng có màu hồng nhạt (trên người sống), màu xám (trên người đã chết). Bề mặt buồng trứng thường nhẵn nhụi cho tới tuổi dậy thì, sau tuổi này, mặt buồng trứng sần sùi, vì hàng tháng thường có 1 trứng (ovum) được giải phóng, làm rách vỏ buồng trứng và để lại vết sẹo trên bề mặt buồng trứng. Từ thời kỳ mãn kinh, bề mặt buồng trứng nhẵn dần trở lại.

1.1.1 Hình thể ngoài và liên quan

Buồng trứng có hình hạt đậu dẹt theo hướng trong ngoài, ở tư thế đứng, trục của buồng trứng đứng thẳng, nên buồng trứng có hai mặt: mặt trong và ngoài, hai bờ: Trước và sau, hai đầu (cực): Trên và dưới. Buồng trứng cao 3cm, rộng (trước - sau) 2cm và dày (trong - ngoài) 1cm.

1.1.1.1 Các mặt:

- Mặt trong (facies medialis) có các tua vòi tử cung úp vào và liên quan với các quai ruột. Bên trái, buồng trứng còn liên quan với đại tràng xích ma, bên phải liên quan với manh tràng và ruột thừa. Nhiễm trùng buồng trứng phải dễ nhầm với viêm ruột thừa.

- Mặt ngoài (facies lateralis), buồng trứng nằm áp vào phúc mạc thành bên chậu hông bé, trong một hố lõm gọi là hố buồng trứng (fossa ovarica). Hố buồng trứng được giới hạn bởi các thành phần nằm ngoài phúc mạc đội phúc mạc lên: Phía trên là động mạch chậu ngoài, phía dưới là động mạch tử cung và phía sau là động mạch chậu trong cùng niệu quản. Ở đáy hố, trong mô liên kết ngoài phúc mạc có bó mạch thần kinh bịt. Vì vậy, trong trường hợp viêm buồng trứng có thể có cảm giác đau lan tới mặt trong của đùi. Ở mặt

ngoài, có một vết lõm là rốn buồng trứng – nơi mạch và thần kinh đi vào và ra khỏi buồng trứng.

1.1.1.2 Các bờ:

- Bờ mạc treo (margo mesovaricus) hay bờ trước, có mạc treo dính vào. Mạc treo này treo buồng trứng vào mặt sau dây chằng rộng.

- Bờ tự do (margo liber) hay bờ sau, liên quan với các quai ruột.

1.1.1.3 Các đầu:

- Đầu vòi (extremitas tubaria) hay đầu trên, là nơi bám của dây chằng treo buồng trứng. Trong dây chằng có mạch thần kinh buồng trứng.

- Đầu tử cung (extremitas uterina) hay đầu dưới, đầu này nhỏ hơn đầu trên, hướng về phía tử cung và là nơi bám của dây chằng riêng buồng trứng.

1.1.2 Cấu tạo

Buồng trứng không có phúc mạc che phủ, mà được bao phủ bởi lớp áo trắng. Ngay dưới lớp áo trắng là lớp vỏ buồng trứng. Dưới lớp vỏ, thuộc phần trung tâm là tủy buồng trứng.

- Lớp áo trắng (tunica albuginea) là lớp tế bào trụ bao phủ mặt ngoài buồng trứng. Vùng chuyển tiếp giữa lớp tế bào trụ của áo trắng với lớp phúc mạc là một đường mảnh, dọc theo bờ mạc treo của buồng trứng.

- Vỏ buồng trứng (cortex ovarii) là lớp dày nằm ngay dưới lớp áo trắng. Lớp vỏ buồng trứng chứa các nang trứng (folliculi ovarii) và thể vàng (corpus luteum).

- Tủy có ở phần trung tâm của buồng trứng, trong tủy có nhiều tế bào cơ trơn và các mạch máu, nhất là các tĩnh mạch.

- Nang trứng, ở bé gái mới ra đời, buồng trứng có rất nhiều nang trứng, được gọi là nang trứng nguyên thủy. Mỗi nang trứng nguyên thủy có một noãn là tế bào trung tâm lớn. Trong thời kỳ thiếu niên và dậy thì rất nhiều nang trứng bị thoái hóa. Từ tuổi dậy thì, một số nang trứng nguyên thủy phát triển hàng tháng tạo nên nang trứng bọc (folliculi ovarii vesiculosi) hay nang trứng chín. Một trong số nang trứng chín này vỡ ra, tạo nên hiện tượng rụng trứng (ovulatio).

- Sau khi phóng noãn, phần còn lại của nang trứng tạo thành một vật thể màu vàng, được gọi là thể vàng. Nếu không có sự thụ tinh, thì thể vàng có đường kính khoảng 1cm và hoạt động từ 12-14 ngày sau rụng trứng, sau đó thoái hóa thành thể trắng, thể trắng sau vài tháng mới biến mất. Trong thể vàng, ngoài những tế bào to sinh sản ra hormon progesteron, còn có các tế bào cạnh vàng (paraluteal cells) nhỏ tiết ra estrogen. Ở người mang thai, thể vàng phát triển suốt giai đoạn mang thai và có đường kính khoảng 2,5cm.

1.1.3 Phương tiện giữ buồng trứng

Buồng trứng được treo lơ lửng trong ổ phúc mạc nhờ hệ thống các dây chằng, gồm:

- Mạc treo buồng trứng, đi từ bờ mạc treo buồng trứng tới lá sau của dây chằng rộng. Buồng trứng không được phúc mạc che phủ hoàn toàn như các tạng khác, mà phúc mạc chỉ bám vào buồng trứng theo một đường dọc theo bờ mạc treo.

- Dây chằng treo buồng trứng (ligamentum suspensorium ovarii), đi từ đầu vòi trứng, chạy trong 2 lá của dây chằng rộng đến thành chậu hông, dây này có thể lan lên phía trên tới vùng thắt lưng. Dây này cấu tạo chủ yếu bởi mạch và thần kinh của buồng trứng và đội phúc mạc lên thành một nếp.

- Dây chằng riêng buồng trứng (ligamentum ovarii proprium), đi từ đầu tử cung đến sừng tử cung, ngay dưới sau vòi tử cung. Dây này cũng đi trong 2 lá của dây chằng rộng.

- Dây chằng vòi – buồng trứng, dây này ngắn, đi từ đầu vòi buồng trứng tới mặt ngoài của phễu vòi, có tua buồng trứng dính vào.

1.1.4 Mạch và thần kinh của buồng trứng

- Động mạch

Buồng trứng được cấp máu bởi các nhánh của hai động mạch là động mạch buồng trứng và động mạch tử cung.

+ Động mạch buồng trứng (a. ovarica) tách ra ở động mạch chủ bụng, dưới nguyên uỷ của động mạch thận. Động mạch đi xuống, sau phúc mạc, đến eo trên, động mạch bắt chéo động, tĩnh mạch chậu ngoài, rồi chạy trong dây chằng treo buồng trứng. Động mạch chia làm hai nhánh tận là động mạch buồng trứng ngoài, đi vào buồng trứng và động mạch vòi tử cung ngoài, chạy dọc theo phía dưới vòi tử cung. Các nhánh này tiếp nối với các nhánh động mạch buồng trứng trong và vòi tử cung trong - nhánh của động mạch tử cung. Động mạch buồng trứng còn cho nhánh bên cấp máu cho niệu quản.

+ Động mạch tử cung (được trình bày ở phần tử cung)

- Tĩnh mạch đi theo động mạch và tạo nên đám rối hình dây leo (plexus pampiniformis) ở gần buồng trứng.

- Bạch huyết theo các mạch đổ về các hạch bạch huyết ở vùng thắt lưng.

- Thần kinh tách từ đám rối buồng trứng (plexus ovaricus) đi theo động mạch buồng trứng để vào buồng trứng.

1.1.5 Vật trên buồng trứng và vật cạnh buồng trứng

- Vật trên buồng trứng (epoophoron – cơ quan Rosenmuler) là di tích của ống trung thận. Nó gồm 10-15 tiểu quản ngang, hội tụ về phía buồng trứng. Một đầu của tiểu quản đóng kín, đầu kia mở vào một ống dọc, gọi là ống dọc trên buồng trứng. Giữa vật trên buồng trứng và tua vòi trứng có một vài bong nhỏ là di tích của ống trung thận, gọi là mẫu phụ hình bóng (appendices vesiculosae).

- Vật cạnh buồng trứng (paroophoron) cũng là di tích của ống trung thận. Vật cạnh buồng trứng gồm một vài tiểu quản rải rác, nằm trong dây chằng rộng, giữa vật trên buồng trứng và tử cung.

1.2 Vòi tử cung

Vòi tử cung (tuba uterina), còn gọi là vòi trứng hay vòi Fallope là ống dẫn trứng từ buồng trứng vào tử cung; gồm hai ống dài khoảng 12cm, đi từ buồng trứng tới góc bên của tử cung, nằm giữa hai lá của dây chằng rộng và chạy theo bờ tự do của dây này.

1.2.1 Hình thể ngoài

Vòi tử cung được chia làm 4 đoạn, mà lần lượt từ ngoài vào trong là:

1.2.1.1 *Phễu vòi* (infundibulum tubae uterinae) dài khoảng 1cm, loe ra như hình cái phễu, ở giữa là lỗ bụng của vòi tử cung (ostium abdominale tubae uterinae). Qua lỗ này, vòi tử cung thông với ổ phúc mạc và để nhận trứng ở buồng trứng vào vòi. Xung quanh lỗ, phễu vòi có khoảng 10- 12 tua vòi (fimbriae tubae), trong đó có một tua dài nhất là tua buồng trứng có tác dụng hứng trứng rụng đưa vào vòi tử cung. Trong thời kỳ rụng trứng nhờ các nội tiết tố, các tua này cương lên giúp việc hứng trứng rụng đưa vào vòi tử cung. Phễu vòi có hai mặt, mặt trong có các tua vòi và úp vào mặt trong buồng trứng.

1.2.1.2 *Bóng vòi* (ampulla tubae uterinae) dài 7- 8cm và đường kính 7- 8mm, là đoạn phình ra to nhất của vòi tử cung. Đoạn này chạy dọc theo bờ mạc treo buồng trứng, giữa đoạn bóng và eo hợp với nhau tạo thành góc vuông. Hiện tượng thụ tinh được thực hiện ở 1/3 ngoài vòi tử cung (đoạn bóng). Trong triết sản, người ta thường thắt và cắt vòi tử cung ở đoạn này.

1.2.1.3 *Eo vòi* (isthymus tubae uterinae) dài 3-4cm và đường kính 3-4mm, là đoạn hẹp nhất của vòi tử cung. Đoạn eo tiếp theo đoạn bóng vòi cho tới dính vào góc tử cung. Vì là nơi hẹp nhất, nên thường tắc vòi tử cung ở đoạn này. Thông thường trứng sau khi đã được thụ tinh sẽ di chuyển về tử cung để làm tổ và phát triển tại đó, vì một lý do nào đó mà thường do tắc đoạn eo, làm cho trứng không về tử cung được mà phát triển tại vòi tử cung, gọi là chửa ngoài tử cung và thường sau 2-3 tháng sẽ gây ra vỡ vòi tử cung (chửa ngoài tử cung vỡ).

1.2.1.4 *Phần tử cung* (pars uterina) dài 1cm, đường kính 5mm, xuyên qua chiều dày của thành tử cung và thông vào buồng tử cung bởi lỗ tử cung của vòi (ostium uterium tubae).

1.2.2 Cấu tạo

Vòi tử cung được cấu tạo gồm 4 lớp mà lần lượt từ ngoài vào trong là:

- Lớp thanh mạc do phúc mạc tạo nên, liên tiếp ở trong với thanh mạc tử cung.

- Lớp dưới thanh mạc

- lớp cơ: Gồm 2 lớp, lớp dọc ở ngoài và lớp vòng ở trong, những lớp cơ này liên tiếp với các lớp cơ của tử cung.
- Lớp niêm mạc có nhiều nếp niêm mạc chạy dọc theo trục của vòi tử cung. Trên bề mặt của lớp niêm mạc là lớp tế bào có lông chuyển, chỉ chuyển động theo một chiều từ ngoài vào trong, có tác dụng đưa trứng về tử cung.

1.2.3 Mạch và thần kinh

Động mạch và tĩnh mạch là những nhánh của mạch tử cung và buồng trứng, chúng chạy dọc theo phía dưới của vòi. Trong thời kỳ có thai dưới tác dụng của nội tiết tố nữ làm mạch máu giãn nở. Vì vậy khi chữa ngoài tử cung vỡ, các mạch máu bị đứt, bệnh nhân rất dễ bị sốc do mất máu quá nhanh.

Bạch mạch và thần kinh cũng giống như của buồng trứng.

1.3 Tử cung (uterus)

Tử cung (dạ con) là nơi nung nấu và phát triển thai nhi, đồng thời còn là nơi sinh ra kinh nguyệt. Khi thai nhi đủ tháng, sự co bóp của cơ tử cung đã góp phần đẩy thai nhi ra ngoài.

1.3.1 Vị trí, hình thể và hướng

- Vị trí: Tử cung nằm giữa trong chậu hông bé: ở trên âm đạo, ở dưới các quai ruột, ở trước trực tràng và ở sau bàng quang.

- Hình thể: Tử cung khi không có thai có hình nón cụt, dẹt theo chiều trước sau, đáy hướng lên trên. Tử cung gồm có 3 phần là thân, eo và cổ tử cung. Kích thước tử cung thay đổi theo tình trạng có thai hay không. Khi không có thai, tử cung dài (cao) 7-8 cm (tùy theo tác giả), trong đó thân tử cung dài khoảng 5cm, cổ tử cung 2,5cm và eo khoảng 0,5cm. Chiều dày của tử cung (trước - sau) 2cm, 1cm cho mỗi thành và tử cung nặng từ 30-40g.

- Hướng, chiều: Tư thế bình thường của tử cung là gấp ra trước và ngả ra trước (hình...)

Tử cung được gọi là gấp ra trước (anteflexio), khi trục của thân tử cung hợp với trục của cổ tử cung một góc 120° quay ra phía trước.

Tử cung được gọi là ngả ra trước (anteversio), khi trục của thân tử cung hợp với trục của chậu hông hay trục của âm đạo một góc vuông quay ra trước.

Đây là tư thế lý tưởng của tử cung (tử cung trung gian) làm cho trọng tâm của tử cung rơi ra phía trước trục âm đạo, để tử cung không bị sa xuống âm đạo, cũng là góp phần giữ thai nhi trong tử cung. Vì vậy, một trong những nguyên tắc chữa sa tử cung là làm tử cung gấp ra trước và ngả ra trước.

1.3.2 Hình thể ngoài và liên quan

1.3.2.1 Thân tử cung (corpus uteri)

Vì thân tử cung hình nón cụt và dẹt theo chiều trước sau nên thân tử cung có hai mặt (trước - dưới hay mặt bàng quang và sau trên hay mặt ruột), hai bờ ở bên, đáy ở trên và hai góc.

- Mặt bàng quang (facies vesicalis) lồi, hướng về phía trước và dưới. Về liên quan: phúc mạc phủ mặt bàng quang của tử cung đến eo tử cung thì lật lên trên và ra trước để phủ mặt đáy bàng quang tạo thành túi cùng bàng quang - tử cung (excavatio vesicouterina). Qua phúc mạc, tử cung liên quan với bàng quang. Vì vậy trong những trường hợp có thai ở tháng cuối, khối thai ép vào bàng quang, làm thai phụ hay đi tiểu vặt.

- Mặt ruột (facies intestinalis) lồi, hướng lên trên và ra sau. Về liên quan: Phúc mạc phủ mặt trên sau bàng quang cho tới eo thì vẫn tiếp tục phủ cho tới 1/3 trên âm đạo rồi lật lên phủ mặt trước trực tràng, tạo nên túi cùng (ổ lõm) tử cung - trực tràng (excavatio rectouterina) hay túi cùng Douglas. Qua phúc mạc, tử cung liên quan với các quai ruột non, đại tràng xích ma và trực tràng. Túi cùng này là nơi thấp nhất ổ phúc mạc, nên dịch trong ổ phúc mạc sẽ đọng lại ở đây.

- Bờ: hai bờ tử cung (phải và trái) dày và tròn, có dây chằng rộng bám. Dọc bờ bên giữa hai lá của dây chằng rộng có mạch tử cung và vật cạnh buồng trứng - di tích của ống trung thân.

- Đáy tử cung (fundus uteri) là bờ trên của thân, có phúc mạc phủ liên tiếp từ mặt bàng quang sang mặt ruột. Đáy cũng liên quan với các quai ruột và đại tràng xích ma.

- Góc (sừng tử cung), hai góc tử cung là nơi gặp nhau giữa hai bờ và đáy tử cung, hai góc tử cung liên tiếp với đoạn eo của hai vòi tử cung. Bám vào góc tử cung gồm: vòi tử cung ở trên, dây chằng riêng buồng trứng ở giữa sau và dây chằng tròn ở dưới trước.

1.3.2.2 Eo tử cung (isthmus uteri)

Eo tử cung là phần thắt hẹp, nằm giữa thân và cổ.

- Phía trước liên quan với bàng quang và đáy túi cùng bàng quang - tử cung. Phúc mạc ở đây dễ bóc khỏi eo tử cung, nên đây là một trong các lý do để rạch vào eo tử cung trong mổ lấy thai.

- Phía sau và hai bên eo tử cung có liên quan như mặt ruột và hai bờ thân tử cung.

1.3.2.3 Cổ tử cung (cervix uteri)

Là phần thấp nhất của tử cung, cổ có hình trụ và hẹp hơn thân. Âm đạo bám vào xung quanh cổ tử cung, chia cổ tử cung làm 3 phần: phần trên âm đạo, phần âm đạo bám và phần trong âm đạo.

- Phần trên âm đạo: Phần này không có phúc mạc bao phủ ở trước, và liên quan ở trước tương tự như eo tử cung. Hai bên cổ có niệu quản chạy chéo xuống dưới và ra trước, bị động mạch tử cung bắt chéo trước niệu quản,

cách cổ tử cung khoảng 1,5cm. Phía sau có phúc mạc phủ, phúc mạc tiếp tục lách xuống để phủ tới 1/3 trên âm đạo rồi lật lên phủ mặt trước trực tràng tạo nên túi cùng tử cung - trực tràng (như đã nêu trên).

- Phần âm đạo bám: âm đạo bám vòng xung quanh cổ tử cung theo một đường chéo xuống dưới và ra trước. Ở phía sau âm đạo bám vào khoảng giữa cổ, còn ở phía trước, âm đạo bám vào 1/3 dưới của cổ.

- Phần trong âm đạo: cổ tử cung thò vào trong âm đạo như một mồm cá mè. Đỉnh của mồm cá mè có lỗ vào tử cung (ostium uteri). Ở người chưa đẻ lần nào lỗ có hình tròn, còn những người đẻ càng nhiều lần thì lỗ càng bè ngang và càng có nhiều vết rách. Lỗ được giới hạn bởi hai môi: môi trước (labium anterius) và môi sau (labium posterius). Lỗ được bịt bởi một nút nhày, nút này có tác dụng tiêu diệt những vi khuẩn, giúp bảo vệ nội mạc tử cung tránh bị viêm nhiễm. Khi chuyển dạ, dưới tác dụng của những cơn co tử cung, kết hợp với hiện tượng xóa, mở cổ tử cung đã đẩy nút nhày này ra ngoài. Đây là một trong những dấu hiệu của chuyển dạ.

Thành âm đạo quay xung quanh cổ tử cung và bịt kín ở trên tạo nên vòm âm đạo (fornix vaginae). Vòm âm đạo là một túi bịt vòng, gồm 4 phần: phần trước, phần sau và hai phần bên. Phần sau sâu nhất và liên quan trực tiếp với túi cùng Douglas. Nên qua túi cùng sau này có thể thăm khám, hay thực hiện một số thủ thuật với túi cùng này. Còn túi cùng bên liên quan mật thiết với niệu quản, và qua thăm khám túi cùng bên âm đạo có thể phát hiện được sỏi niệu quản.

1.3.3 Hình thể trong (hình...)

Lòng của tử cung là một khoang dẹt theo hướng trước sau, có một chỗ hẹp tương ứng với eo, chia lòng tử cung làm hai phần: trên là buồng (ổ) tử cung và dưới là ống cổ tử cung.

1.3.3.1 Buồng tử cung hay ổ (cavitas uteri) là một khoang dẹt vì hai thành trước và sau tử cung như áp sát vào nhau, hình tam giác mà đáy là mặt trong đáy tử cung, đáy hơi lõm ở người chưa đẻ, phẳng hay lõm ở những người đã đẻ hay đẻ nhiều lần. Hai bờ bên cũng lõm. Hai góc trên là hai lỗ tử cung của vòi tử cung. Góc dưới thông với ống cổ tử cung qua chỗ hẹp của eo.

1.3.3.2 Ống cổ tử cung (canalis cervicis uteri)

Là một ống hình thoi, rộng ở giữa và hẹp ở hai đầu. Ở trên, ống thông với ổ tử cung qua một chỗ hẹp tương ứng với eo ở ngoài (lỗ trong cổ tử cung). Ở dưới, ống thông với âm đạo qua lỗ vào tử cung.

Ở các thành trước và sau của ống có một lồi dọc, nằm không đúng đường giữa và hai lồi này không đè lên nhau. Từ mỗi lồi dọc có các nếp chạy chéo lên trên và ra ngoài, gọi là nếp lá cọ (plicae palmatae).

1.3.4 Cấu tạo

Thành tử cung gồm 4 lớp, mà lần lượt từ ngoài vào là:

1.3.4.1 *Áo thanh mạc* (tunica serosa) là lớp phúc mạc, ở hai bờ của thân tử cung không có phúc mạc che phủ. Phúc mạc ở mặt bàng quang và mặt ruột bao phủ khác nhau (như đã nêu trên)

1.3.4.2 *Tấm dưới thanh mạc* (tela subserosa)

Là lớp mô liên kết sợi, dính vào tử cung.

1.3.4.3 *Áo cơ* (tunica muscularis) là lớp dày nhất của tử cung. Ở phụ nữ chưa sinh, lớp này rất dày và chắc, cắt qua lớp này có cảm giác như cắt qua sụn, dày 1,25cm (ở thân). Lớp cơ gồm các sợi cơ trơn đan xen với mô liên kết, mạch máu và thần kinh. Trong thời kỳ mang thai, lớp cơ này rất phát triển.

Áo cơ gồm 3 lớp:

- Lớp ngoài chủ yếu là những sợi dọc, chạy về phía đáy tử cung và hội tụ ở 2 sừng tử cung, đồng thời liên tiếp với cơ ở vòi tử cung.

- Lớp giữa là lớp cơ rối, các sợi chạy theo nhiều hướng, đan chéo nhau, chằng chịt quay xung quanh các mạch máu. Khi lớp cơ này co có tác dụng cầm máu sau đẻ. Trường hợp đỡ tử cung, do lớp cơ này không co hay co không đủ mạnh sẽ gây chảy máu sau đẻ (băng huyết).

- Lớp trong là lớp cơ vòng.

Ở cổ tử cung lớp cơ mỏng hơn nhiều và cũng gồm 3 lớp, trong đó lớp giữa là cơ vòng mà không có lớp cơ rối.

1.3.4.4 *Áo niêm mạc* (tunica mucosa) hay nội mạc tử cung (endometrium).

Niêm mạc tử cung thay đổi theo từng giai đoạn của chu kỳ kinh nguyệt, hàng tháng niêm mạc bong ra, kết hợp chảy máu tạo nên kinh nguyệt. Trong lớp niêm mạc có nhiều tuyến, gọi là tuyến tử cung.

1.3.5 *Phương tiện giữ tử cung tại chỗ*

Ngoài vị trí (âm đạo bám vào dưới tử cung quanh cổ tử cung), hướng (gấp và ngả ra trước), tử cung còn được giữ tại chỗ bởi các dây chằng, gồm: dây chằng rộng, dây chằng tròn, dây chằng tử cung-cùng và dây chằng ngang cổ tử cung. Nhưng tác dụng giữ tử cung của những dây này cũng rất hạn chế.

1.3.5.1 *Dây chằng rộng* (ligamentum latum uteri)

Dây chằng rộng là một nếp phúc mạc gồm có hai lá, liên tiếp với phúc mạc ở mặt bàng quang và mặt ruột của tử cung, từ bờ bên của tử cung tới thành bên chậu hông. Dây chằng rộng gồm: hai mặt và 4 bờ.

- Mặt trước dưới liên quan với bàng quang và có một nếp phúc mạc đi từ góc bên tử cung chạy xuống dưới, ra trước tới lỗ bẹn sâu, đó là do dây chằng tròn đội lên.

- Mặt sau trên liên quan với các quai ruột và kết tràng xích – ma, có dây chằng riêng buồng trứng đội phúc mạc lên và có mạc treo buồng trứng.

- Bờ trong dính vào bờ bên tử cung

- Bờ ngoài dính vào thành chậu hông, do 2 lá của dây chằng rộng liên tiếp ra phía trước và phía sau với phúc mạc thành.

- Bờ trên tự do, bọc lấy vòi tử cung.
- Bờ dưới gọi là đáy dây chằng rộng, nơi hai lá phúc mạc tách nhau ra để liên tiếp với phía trước và phía sau phúc mạc thành.

Ở đáy dây chằng rộng có động mạch tử cung bắt chéo phía trước niệu quản.

Phần dây chằng rộng ở trên gọi là phần cánh, gồm 3 cánh là 3 mạc treo: mạc treo vòi tử cung ở trên (cánh trên), mạc treo dây chằng tròn ở trước dưới (cánh trước) và mạc treo buồng trứng ở sau (cánh sau). Giữa hai lá của mạc treo vòi tử cung có vật trên buồng trứng là di tích của ống trung thận.

1.3.5.2 *Dây chằng tròn* (ligamentum teres uteri) là một sợi dây chằng mô liên kết dưới phúc mạc, dài khoảng 15cm, đi từ góc bên tử cung chạy xuống dưới, ra trước, đội lá trước của dây chằng rộng tạo nên cánh trước dây chằng này, tới lỗ (vòng) bẹn sâu, chui vào trong ống bẹn, ra lỗ bẹn nông rồi toả ra thành nhiều sợi nhỏ và tận hết ở mô liên kết của gò mu và môi lớn của âm hộ. Đi cùng dây này chui vào ống bẹn còn có mạch, thần kinh và bạch huyết. Các mạch bạch huyết chạy theo dây chằng tròn, nhận bạch huyết từ phần trên tử cung để tới các hạch bẹn nông. Vì vậy, ung thư tử cung có thể lan theo đường này.

1.3.5.3 *Dây chằng tử cung- cùng* là một dải mô liên kết và cơ trơn đi từ mặt sau, hai bên cổ tử cung chạy ra sau và lên trên đi hai bên trực tràng để bám vào mặt trước xương cùng. Dây đội phúc mạc lên thành nếp tử cung - trực tràng và tạo nên giới hạn bên của túi cùng tử cung - trực tràng.

1.3.5.4 *Dây chằng ngang cổ tử cung* hay dây chằng Mackenrodt cũng là dải mô xơ liên kết, đi từ bờ bên của cổ tử cung, ngay trên phần bên vòm âm đạo, chạy ngang sang hai bên dưới nền dây chằng rộng, trên hoành chậu hông, để bám vào thành bên chậu hông.

1.3.6 *Mạch và thần kinh*

1.3.6.1 *Động mạch*. Tử cung được cấp máu bởi động mạch tử cung (a. uterina). Động mạch này tách ra từ động mạch chậu trong và đường đi theo 3 đoạn (hình...).

- Đoạn thành bên chậu hông, động mạch áp sát vào mạc cơ bịt trong và tạo nên giới hạn dưới của hố buồng trứng.

- Đoạn nền (đáy) dây chằng rộng, động mạch từ thành bên chậu hông chạy ngang vào trong, giữa 2 lá của dây chằng rộng, bắt chéo phía trước niệu quản cách cổ tử cung khoảng 1,5cm, cần thận trọng để tránh thất nhầm phải niệu quản khi thắt động mạch tử cung.

- Đoạn bờ bên tử cung, từ nền dây chằng rộng, động mạch đi tới sát bờ bên cổ tử cung, rồi quặt lên chạy dọc xoắn hình lò xo theo bờ bên thân tử cung tới góc tử cung thì chia làm hai nhánh cùng.

Nhánh bên, trên đường đi động mạch tách ra nhiều nhánh bên cho cổ tử cung, âm đạo, thân tử cung...

Ngành cùng là: động mạch buồng trứng, vòi tử cung, đi ra ngoài để tiếp nối với các nhánh tương ứng ở phía ngoài được tách ra từ động mạch buồng trứng.

1.3.6.2 *Tĩnh mạch*. Máu từ tử cung được đổ vào đám rối tĩnh mạch dày đặc nằm hai bên thân tử cung. Các đám rối này nối với các tĩnh mạch buồng trứng, rồi cùng đổ về tĩnh mạch tử cung (v. uterinae) và sau cùng đổ về tĩnh mạch chậu trong.

1.3.6.3 *Bạch huyết*. Các bạch mạch ở thân và cổ tử cung thông nối với nhau và đổ vào thân chung, chạy dọc bên ngoài động mạch tử cung và cuối cùng các bạch mạch đổ vào các hạch theo động mạch chậu trong hay động mạch chủ bụng.

1.3.6.4 *Thần kinh*. Tử cung được chi phối bởi đám rối thần kinh tử cung - âm đạo (plexus uterovaginalis). Đám rối này tách ra từ đám rối hạ vị dưới (plexus hypogastricus inferior) đi trong dây chằng tử cung - cùng để tới tử cung ở eo tử cung.

1.4 Âm đạo (vagina)

Âm đạo là ống cơ mạc, bám từ cổ tử cung tới tiền đình âm hộ. Ống rất đàn hồi, dài trung bình 8cm. Âm đạo nằm sau bàng quang, trước trực tràng, chạy chéo ra trước và xuống dưới theo trục chậu hông, nên trục âm đạo hợp với đường ngang một góc 70° quay ra phía sau. Hai thành trước và sau âm đạo áp sát vào nhau và thành sau dài hơn thành trước 1-2cm.

1.4.1 *Liên quan*. Âm đạo có hai thành trước và sau, hai bờ bên và hai đầu trên và dưới (hình...).

- Thành trước (paries anterior) liên quan ở trên với bàng quang và niệu quản, ở dưới với niệu đạo. Giữa âm đạo và các cơ quan này là một tổ chức liên kết. Trong trường hợp đẻ khó, có thể dò bàng quang - âm đạo, do thành trước âm đạo bị rách.

- Thành sau (paries posterior) liên quan từ trên xuống dưới với túi cùng tử cung - trực tràng, rồi tới mặt trước trực tràng cho tới tận mạc đáy chậu. Ở phía trên lớp mạc cơ đáy chậu, khi âm đạo tiếp tục chạy chéo ra trước thì ống hậu môn bẻ gấp ra phía sau, tạo nên một tam giác giữa âm đạo và ống hậu môn, được gọi là tam giác âm đạo - trực tràng. Âm đạo cũng ngăn cách với trực tràng qua một vách mô liên kết xơ. Có thể bị dò âm đạo trực tràng trong những trường hợp đẻ khó như dò bàng quang âm đạo.

- Bờ bên âm đạo, ở trên, bờ nằm trong khoang chậu hông, liên quan với dây chằng rộng ở đó có niệu quản và các nhánh mạch và thần kinh âm đạo, cũng như mô liên kết trong khoang chậu hông dưới phúc mạc. Ở giữa

âm đạo chọc qua hoành chậu hông. Và ở dưới âm đạo vào vùng đáy chậu, liên quan với cơ khí âm môn, với tuyến tiền đình.

- Đầu trên bám xung quanh vào cổ tử cung tạo thành vòm âm đạo, vòm âm đạo sâu 2cm, liên quan với túi cùng tử cung- trực tràng. Vì vậy, qua vòm sau âm đạo có thể thăm khám hay thực hiện các thủ thuật vào túi cùng này.

- Đầu dưới mở vào tiền đình âm hộ. Ở trình nữ, lỗ của đầu dưới âm đạo được ~~đậy bởi một nếp niêm mạc thủng ở giữa gọi là màng trinh (hymen)~~, sau khi giao hợp màng trinh bị rách, những mảnh rách của màng trinh chung quanh lỗ này, gọi là cục màng trinh (carunculae hymenales). Lỗ dưới âm đạo được các thớ sợi của cơ hành xóp bao quanh như một cơ thắt âm đạo (sphincter vaginae).

- Một số áp dụng lâm sàng: Người nạo thai không chuyên, hay thiếu kinh nghiệm, có thể không nhận thấy tử cung chạy lên trên và ra trước từ đầu trên âm đạo; mà có thể đẩy dụng cụ thẳng ra phía sau qua túi cùng sau âm đạo, thay vì đưa vào cổ tử cung. Dẫn tới thủng túi cùng sau. Điều này càng tồi tệ hơn, vì túi cùng sau là phần duy nhất của âm đạo liên thông với phúc mạc, nên dụng cụ đi vào ổ phúc mạc và gây ra viêm phúc mạc.

Về già, cả chiều dài và đường kính âm đạo co lại, cổ tử cung nhô rất ít vào âm đạo, do đó các túi cùng âm đạo gần như biến đi.

1.4.2 Hình thể trong và cấu tạo

Ở mặt trong âm đạo, niêm mạc tạo nên những nếp ngang gọi là các nếp nhăn âm đạo (rugae vaginales). Trên mặt trong của thành trước và thành sau âm đạo lại có các lồi dọc gọi là cột nếp nhăn (columnae rugarum), có cột nếp nhăn trước và cột nếp nhăn sau. Cột nếp nhăn trước thường phát triển hơn cột nếp nhăn sau. Ở phụ nữ sau đẻ những nếp nhăn này sẽ giảm đi.

Về cấu tạo: Âm đạo được cấu tạo bởi hai lớp: Áo cơ là lớp ngoài gồm hai loại thớ: thớ dọc ở ngoài và thớ vòng ở trong. Xung quanh áo cơ có mạc bao bọc và được liên tiếp với mô liên kết của chậu hông; vì vậy âm đạo được giữ chắc tại vị trí. Áo niêm mạc tạo nên các nếp và các cột như đã nêu trên.

Niêm mạc dính chặt vào lớp cơ và được cấu tạo bởi lớp biểu mô lát tầng không sừng hoá. Sau dậy thì lớp biểu mô này dày lên và có chứa nhiều glycogen. Glycogen tăng lên sau khi trứng rụng và giảm dần cho tới cuối kỳ kinh. Niêm mạc âm đạo không có tuyến nhầy, chất nhầy trong âm đạo do các tuyến ở cổ tử cung tiết ra và ở tiền đình đổ vào.

1.4.3 Tiền đình âm đạo (vestibulum vaginae)

1.4.3 Mạch và thần kinh

- Động mạch, âm đạo được cấp máu bởi các nhánh tách ra từ động mạch tử cung hoặc từ động mạch trực tràng giữa hoặc trực tiếp từ động mạch chậu trong.

- Tĩnh mạch tạo thành một đám rối tĩnh mạch âm đạo nối với đám rối tử cung ở trên, đám rối bàng quang ở trước và sau cùng đổ vào tĩnh mạch chậu trong.

- Bạch huyết đổ vào chuỗi hạch tử cung hoặc động mạch âm đạo rồi vào các hạch chậu.

- Thần kinh: chi phối cho âm đạo gồm các nhánh âm đạo tách ra từ đám rối tử cung—âm đạo (plexus uterovaginalis) và từ các nhánh thần kinh tạng chậu hông (nervi splanchnici pelvici). Phần dưới âm đạo được chi phối bởi thần kinh thẹn trong (nervus pudendus).

2. Bộ sinh dục ngoài của nữ

Bộ sinh dục ngoài của nữ gồm có âm hộ, âm vật và vú

2.1 Âm hộ (pudendum femininum) gồm có gò mu, môi lớn, môi bé và tiền đình.

2.1.1 *Gò mu* (mons pubis) là một mô nổi lên ở trước âm hộ liên tiếp phía dưới với môi lớn, phía trên với thành bụng và hai bên với nếp lằn bẹn. Ở dưới nếp da gò mu là một lớp tổ chức mỡ rất dày.

2.1.2 *Môi lớn* (labium majus pudendi) là hai nếp da lớn giới hạn hai bên âm hộ. Môi lớn dài khoảng 8cm và rộng 2cm, ngăn cách với da đùi gọi là rãnh sinh dục đùi. Môi lớn có hai mặt: mặt ngoài được phủ bởi lớp da sẫm màu vì có nhiều sắc tố, nhiều tuyến bã và có lông (từ tuổi dậy thì); mặt trong nhẵn, màu hồng, ngăn cách với môi bé bởi rãnh liên môi. Bờ trong tự do giới hạn nên khe âm hộ (rima pudendi). Hai môi lớn gặp nhau ở phía trước tạo thành mép môi trước (commissura labiorum anterior) có nhiều lông mu che phủ và gặp nhau ở phía sau gọi là mép môi sau (commissura labium posterior) cách hậu môn khoảng 3cm. Về cấu tạo, môi lớn gồm có da, lớp cơ trơn dartos và một lớp mỡ dày có nhiều sợi chun đàn hồi. Dây chằng tròn qua ống bẹn sẽ toả ra và bám vào đây. Thoát vị bẹn ở nữ tuy là rất hiếm gặp, có thể xảy ra ở đây.

2.1.3 *Môi bé âm hộ* (labium minus pudendi)

Là hai nếp da nhỏ, không có mô mỡ, dài khoảng 5cm, rộng 0,5 cm, nằm ở phía trong môi lớn, ngăn cách với môi lớn bởi rãnh liên môi. Đầu trước môi bé tách ra một nếp nhỏ, ở trên bọc lấy âm vật tạo nên bao âm vật, ở dưới tạo nên hãm âm vật. Đầu sau dính với môi bé bên đối diện tạo nên hãm môi âm hộ (frenulum labiorum pudendi).

2.1.4 *Tiền đình âm đạo* (vestibulum vaginae)

Là một chỗ lõm như một cái hố nằm ở giữa mặt trong hai môi bé, phía trước có âm vật, phía sau là hãm môi âm hộ. Qua tiền đình mới vào tới âm đạo. Ở trình nữ, màng trinh ngăn cách giữa âm đạo và tiền đình. Màng trinh là một nếp, với 2 lá niêm mạc, có các môi che đậy. Ở giữa màng trinh có lỗ

hay có khe thông âm đạo với tiền đình. Có khi màng trinh có nhiều lỗ, hiếm thấy màng trinh bịt kín.

Đáy tiền đình có lỗ ngoài niệu đạo, lỗ âm đạo, hành tiền đình, ngoài ra còn có các lỗ đổ của các tuyến sinh dục: tuyến tiền đình lớn và tuyến tiền đình bé.

- Lỗ ngoài niệu đạo, ở trước lỗ âm đạo và sau qui đầu âm vật khoảng 2,5cm.

- Lỗ âm đạo là một khe dọc hình bầu dục, phía trước là cục niệu đạo (là một móc quan trọng để xác định lỗ ngoài niệu đạo, để thông đại) và phía sau là hãm môi âm hộ.

- Hành tiền đình (bulbus vestibuli) là hai khối mô cương nằm ở hai bên lỗ âm đạo. Tương tự như hành xộp ở nam giới, nhưng bị âm đạo tách ra làm đôi. Hành tiền đình có cơ hành xộp bọc xung quanh, một số sợi cơ này tách ra tạo thành cơ thất âm môn nằm phía trong của hành. Khi cơ cương (hành xộp) co làm cương hai hành tiền đình. Hành tiền đình dài 3,5cm, rộng 1,5cm và dày 1cm, như một con đĩa đầy máu.

- Tuyến hành tiền đình lớn (glandula vestibularis major), còn gọi là tuyến Bartholin, gồm hai tuyến hình trứng nằm hai bên lỗ âm đạo, phía sau khối bên hành tiền đình. Mỗi tuyến có một ống dài khoảng 2cm, đổ vào rãnh giữa chỗ bám màng trinh vào môi bé. Trong thời kỳ hoạt động sinh dục tuyến dài từ 10-15mm, cao 8mm và dày 5mm. Phía ngoài của tuyến có cơ hành xộp, khi cơ này co sẽ ép vào tuyến gây tiết dịch đổ vào tiền đình.

2.2 Âm vật (clitoris)

Là một mô cương tương đương với dương vật ở nam giới. Âm vật nằm ngay dưới đầu trước khe âm hộ, phía dưới và phía sau mép môi trước.

Âm vật gồm có thân và hai trụ. Thân âm vật gồm hai vật hang. Vật hang được tạo nên bởi mô cương bọc trong một bao sợi. Hai vật hang ở thân âm vật được ngăn cách nhau bởi vách vật hang. Mỗi vật hang có hai đầu mà đầu sau nằm dọc theo ngành ngồi mu, gọi là trụ âm vật (crus clitoridis). Đầu trước của hai âm vật chụm lại tạo nên một củ tròn, rất nhạy cảm gọi là qui đầu âm vật (glans clitoridis). Nếp trên của đầu trước môi bé chạy vòng lên trên âm vật, cùng với nếp tương ứng bên đối diện tạo nên bao âm vật (preputium clitoridis), còn nếp dưới của đầu trước môi bé chạy phía dưới âm vật và cùng với nếp dưới bên đối diện dính vào mặt dưới âm vật tạo nên hãm âm vật (frenulum clitoridis).

2.3 Mạch và thần kinh của âm hộ và âm vật

- Động mạch của gò mu, môi lớn, môi bé là nhánh của động mạch thẹn ngoài. Động mạch của âm vật, tuyến tiền đình lớn, hành tiền đình là nhánh dây chậu nông, nhánh hang và mu âm vật tách từ động mạch thẹn trong.

- Tĩnh mạch đổ vào các tĩnh mạch mu nông và mu sâu rồi vào các đám rối tĩnh mạch để đổ vào tĩnh mạch thận trong và ngoài.

- Bạch mạch của bộ sinh dục ngoài đổ về hạch bẹn nông. Riêng âm vật đổ về hạch bẹn sâu hoặc các hạch chậu.

- Thần kinh của gò mu, môi lớn là các nhánh sinh dục của thần kinh chậu bẹn và thần kinh sinh dục đùi. Các phần khác là các nhánh đáy chậu của thần kinh thận. Cũng có một số sợi thuộc thần kinh tự chủ từ đám rối hạ vị đi vào hành tiền đình, tuyến hành tiền đình lớn và vật hang âm vật.

2.4 Vú.

Vú (mamma) có nhiệm vụ tiết ra sữa, phát triển mạnh thời gian dậy thì, những tháng cuối thời kỳ có thai, nhất là sau khi sinh đẻ.

Vú nằm ở thành ngực trước đi từ nách tới bờ bên xương ức, và từ xương sườn II- V

Thường có hai vú, trường hợp dị dạng có thể có một dãy vú phụ.

2.4.1 Hình thể ngoài

Vú có hình nửa khối cầu, tròn, lõm hơn ở phía dưới, nên phía dưới tạo với thành ngực một rãnh, gọi là rãnh dưới vú. Rãnh này càng sâu thường ở người càng cao tuổi do vú chảy sệ xuống. Ở trung tâm mặt trước vú có một lõm tròn gọi là nhú vú (papilla mammae) hay đầu vú, có nhiều lỗ nhỏ là lỗ tiết của các ống tiết sữa. Xung quanh núm vú có một vùng da sẫm hơn gọi là quầng vú (areola mammae). Ở quầng vú nổi lên những cục nhỏ, do các tuyến bã của quầng vú đẩy lên.

2.4.2 Cấu tạo

Từ nông vào sâu, vú được cấu tạo bởi (hình...)

- Da mềm mại được tăng cường nhiều sợi cơ trơn ở quầng vú.
- Mô liên kết dưới da tạo thành các hốc mỡ (hay bị áp xe dưới da)
- Các tuyến sữa (glandulae mammaria) là loại tuyến chùm tạo thành các tiểu thùy (lobuli glandulae). Nhiều tiểu thùy hợp thành các thùy (lobi glandulae mammaria), có khoảng 15-20 thùy. Mỗi thùy đổ ra đầu vú bởi một ống tiết sữa (ductus lactiferi). Trước khi đổ ra đầu vú, ống tiết sữa phình ra thành xoang sữa. Các ống tiết sữa chạy từ ngoại vi hướng vào trung tâm là đầu vú như hình nan hoa. Vì vậy, khi rạch áp xe vú, không được rạch theo hướng vuông góc với hướng đi của các ống tiết sữa vì sẽ làm đứt những ống này.
- Lớp mỡ sau vú rất dày ngay trên mạc nông của ngực (hay bị áp xe vú ở đây).

2.4.3 Mạch và thần kinh

- Động mạch là các nhánh tách ra từ động mạch ngực ngoài và động mạch ngực trong.

- Tĩnh mạch tạo thành một mạng nông, nhìn thấy rõ khi có thai hay nuôi con bú. Các tĩnh mạch sâu đổ về tĩnh mạch ngực trong và ngoài.

- Bạch mạch của tuyến vú bắt nguồn từ đám rối bạch huyết trong mô liên kết gian thủy và trong thành các ống sữa. Các mạch này thường thông nối với đám rối bạch huyết dưới da và đặc biệt quanh núm vú với các đám rối dưới quầng vú. Điều này rất quan trọng trong sự lan truyền ung thư từ các cơ quan khác. Nhìn chung bạch huyết vú đổ về 3 chuỗi hạch: chuỗi hạch nách, chuỗi hạch ngực trong và chuỗi trên đòn.

- Thần kinh do các nhánh trên đòn của đám rối thần kinh cổ nông và những nhánh xiên của thần kinh gian sườn II, III, IV, V và VI.